RUTA CLÍNICA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS- ADULTOS

Ámbito: Consulta externa, Urgencias, Hospitalización

CONSULTA DE MORBILIDAD Y/O URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN

1. INGRESO DEL PACIENTE (SOSPECHA CLÍNICA)

SÍNTOMAS URINARIOS	SÍNTOMAS SISTÉMICOS
Disuria Polaquiuria Urgencia urinaria Dolor suprapúbico Hematuria	Fiebre Náuseas/ Vómito Dolor lumbar- puño percusión lumbar positiva Hipotensión Alteración del estado mental

2. SOLICITUD UROANÁLISIS

Hallazgos que apoyan el diagnóstico de IVU	
Leucocituria	≥ 10 leucocitos / campo de alto poder (CAP)
Nitritos	Positivos (muy sugestivos de enterobacterias)
Esterasa leucocitaria	Positiva
Bacteriuria	Moderada (++) o abundante (+++)
Hematuria microscópica	Puede estar presente
Ausencia de moco	Apoya origen urinario (no vaginal)

¿Clínica y uroanálisis compatible con ITU?

- SI → CLASIFICAR ITU EN:
- NO → BUSCAR OTRO DIAGNÓSTICO

3.1 ITU COMPLICADA

Se considera complicada si presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

Obstrucción Urinaria
Litiasis Urinaria
Presencia catéter o dispositivo urinario
Anomalía anatómica o funcional del tracto urinario
Instrumentación vía urinaria reciente
Inmunosupresión
Enfermedad Renal Crónica
Antecedente microorganismos multiresistentes
Pielonefritis
Bacteremia
Sepsis o compromiso sistémico
Embarazo (Revisar protocolo institucional ITU en gestantes)

5. TRATAMIENTO

5.1 ITU COMPLICADA

¿qSOFA ≥ 2?

- NO → INICIAR TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
- SI → ACTIVAR CÓDIGO SEPSIS

5.1.1 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS COMPLICADA/ SISTÉMICO

ESCENARIO CLÍNICO	MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN
Sin uso de antibióticos en los últimos 3 meses y sin instrumentación urinaria	**Cefazolina**	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 8 horas	7–10 días
Uso de antibióticos en los últimos 3 meses o antecedente de instrumentación urinaria	**Cefepime**	Frasco-ampolla 2 g	2 g IV	Cada 12 horas*	7–10 días
Alto riesgo de BLEE	**Ertapenem**	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 24 horas	7–10 días

5.1.2 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS COMPLICADA/ LOCALIZADA

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína	Tableta/Cápsula 100 mg	100 mg VO	Cada 12 horas	5 días	En mujeres posmenopáusicas con TFG ≥45 mL/min y sin sospecha de pielonefritis.
Cefalexina	Cápsula 500 mg	500 mg VO	Cada 6 horas	5 días	Alternativa oral institucional.

Embarazo (Revisar protocolo institucional ITU en gestantes)

3.2 ITU NO COMPLICADA

El diagnóstico de ITU siempre debe correlacionarse con la clínica; un uroanálisis alterado sin síntomas NO confirma infección

4. SOLICITUD OTROS PARACLÍNICOS

CONSULTA DE MORBILIDAD Y/O URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN

4.1 UROCULTIVO

INDICACIONES UROCULTIVO	INTERPRETACIÓN UROCULTIVO
Hombre IVU complicada Pielonefritis Embarazo Catéter urinario Recurrencia Falla terapéutica Riesgo de resistencia (BLEE, Pseudomonas) Hospitalización	**≥10⁵ UFC/mL** de un solo microorganismo en paciente sintomático **10³–10⁵ UFC/mL** de un uropatógeno en paciente con síntomas y leucocituria (especialmente en mujeres y pielonefritis) **≥10² UFC/mL** en mujeres con síntomas típicos de cistitis por *E. coli*

Crecimiento en paciente **sin síntomas urinarios ;** Bacteriuria asintomática (no tratar, excepto embarazo o procedimientos urológicos invasivos)

Sin crecimiento (IVU poco probable si no recibió antibióticos previamente; considerar otras causas o repetir cultivo si la sospecha clínica persiste)

4.2 EN ITU COMPLICADA SOLICITAR: → Hemograma, función renal, PCR

4.3 EN UROSEPSIS SOLICITAR: → **Hemocultivos, Lactato. ACTIVAR CÓDIGO SEPSIS**

4.4 SOLICITAR IMÁGENES EN: → No mejoría clínica después de 48–72 horas de tratamiento antibiótico adecuado, sospecha de obstrucción urinaria o litiasis, sepsis, hematuria persistente, sospecha absceso renal

Cefazolina	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 8 horas	Según evolución clínica	Alternativa para pacientes hospitalizados con cistitis complicada.

5.1 ITU NO COMPLICADA

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína **100 mg**	Tableta/ Cápsula **100 mg**	100 mg **VO**	Cada **12 horas**	**5 días**	**PRIMERA LÍNEA** Contraindicada si TFG <45 mL/min o sospecha de pielonefritis.
Cefalexina **500 mg**	Cápsula **500 mg**	500 mg **VO**	Cada **6 horas**	**5 días**	**SEGUNDA LÍNEA** institucional.
Fosfomicina trometamol **3 g**	Sobre **3 g**	3 g **VO**	Dosis **única**	Dosis **única**	**NO se recomienda su utilización como tratamiento empírico de uso rutinario.** Su uso se restringe como estrategia **PROA** para preservar su eficacia microbiológica y disminuir el riesgo de resistencia bacteriana institucional.

6. REEVALUAR EN 48-72 HORAS



Asociación Colombiana de Infectología (ACIN). **Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias complicadas en adultos.** Bogotá, Colombia: ACIN; 2023

Trautner BW, Cortés-Penfield NW, Gupta K, Hirsch EB, Horstman M, Moran GJ, et al. **Clinical Practice Guideline by the Infectious Diseases Society of America (IDSA): 2025 Guideline on Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections: Selection of Antibiotic Therapy for Complicated UTI.**

European Association of Urology. **EAU Guidelines on Urological Infections 2025.** Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology; 2025.